



Introdução ao Cuidado – Assistência na Nutrição e Eliminações

Enf^a Catharine Souza

Avaliação do Estado Nutricional



Alimentos: substâncias sólidas e líquidas que, levadas ao TGI, são degradadas e, posteriormente, utilizadas p/ formar e/ou manter os tecidos do corpo, regular processos e fornecer calor.

Nutrientes: Essenciais para o bom funcionamento do organismo: carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, sais minerais água. São fornecidos ao organismo através dos alimentos.

Fatores que afetam a nutrição:



▣ Idade;

▣ Sexo;

▣ Estado de Saúde;

▣ Abuso de Álcool;

▣ Uso de Medicações;

▣ Fatores Econômicos;

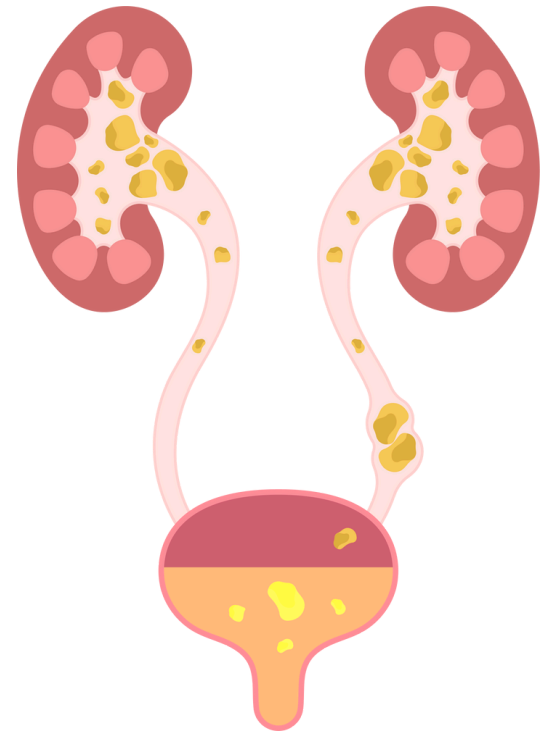
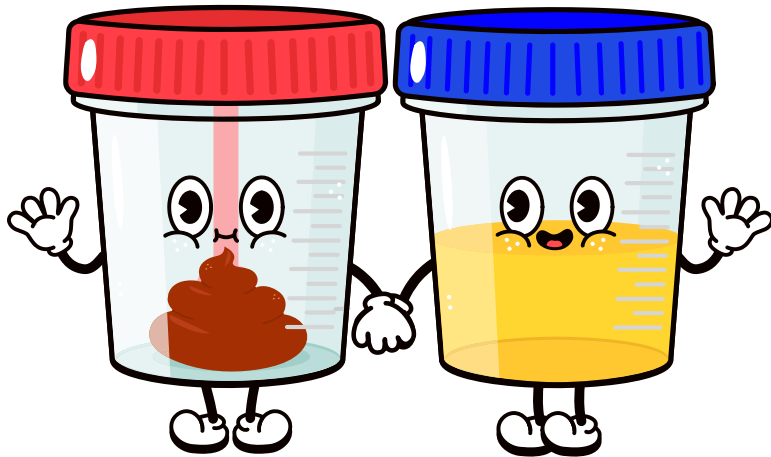
▣ Cultura e Religião;

▣ Padrões alimentares alternativo

Avaliação do Estado Nutricional

- Tônus muscular com reflexos normais;
- • Balanço energético;
- • Ritmo e batimentos cardíacos normais;
- • Pressão arterial normal;
- • Lúcido e orientado no tempo e espaço;
- • Exames laboratoriais, (glicose, albumina, dentre outros)...
- • Fezes moldadas amolecidas, eliminadas regularmente com mínimo esforço;
- • Velocidade normal de crescimento para a idade;

Eliminações



Tipo 01  Pedacos separados,
duros como amendoim

Tipo 02  Forma de salsicha,
mas segmentada

Tipo 03  Forma de salsicha, mas
com fendas na superfície

Tipo 04  Forma de salsicha ou
cobra, lisa e mole

Tipo 05  Pedacos moles,
mas contornos nítidos

Tipo 06  Pedacos aerados,
contornos esgarçados

Tipo 07  Aquosa,
sem peças sólidos

As fezes do tipo 01 e 02
são comuns em indivíduos
com tendência a
**CONSTIPAÇÃO = FEZES
ENDURECIDAS, TRÂNSITO
INTESTINAL LENTO**

As fezes do tipo 03 e 04
são comuns em indivíduos
com
**TRÂNSITO INTESTINAL
REGULAR= FEZES
BRANDAS, IDEAL**

As fezes do tipo 05, 06 e
07 são comuns em
indivíduos com
**TRÂNSITO RÁPIDO OU
DIARRÉIA = FEZES
PASTOSAS OU LÍQUIDAS**

Alterações na Eliminação Intestinal

Constipação intestinal

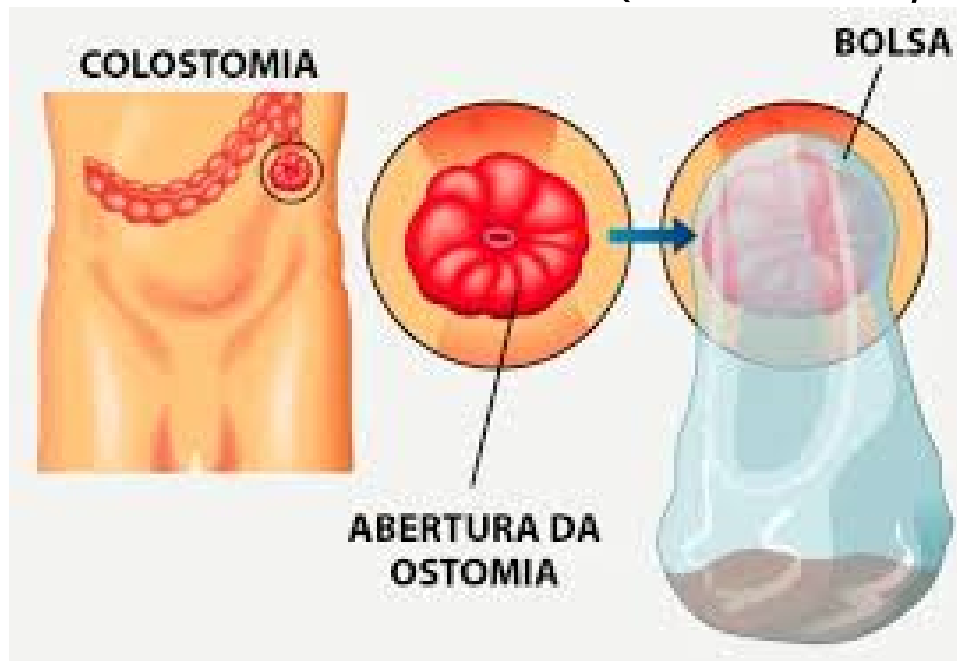
Diarreia

Incontinência fecal

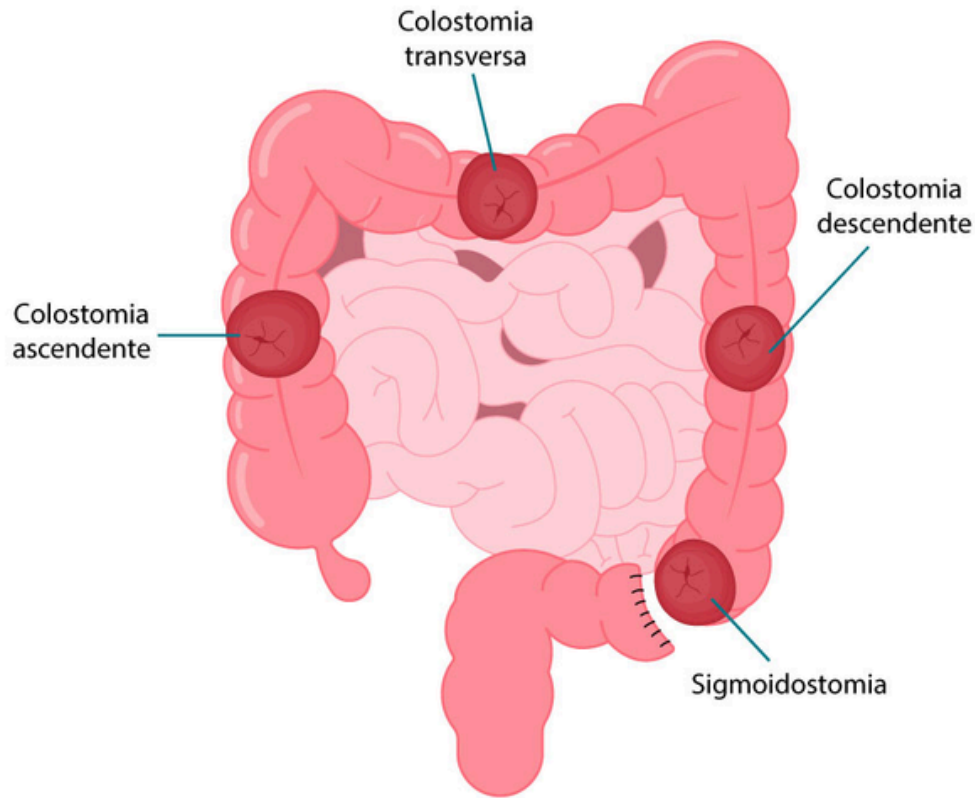
Impactação fecal

Flatulência

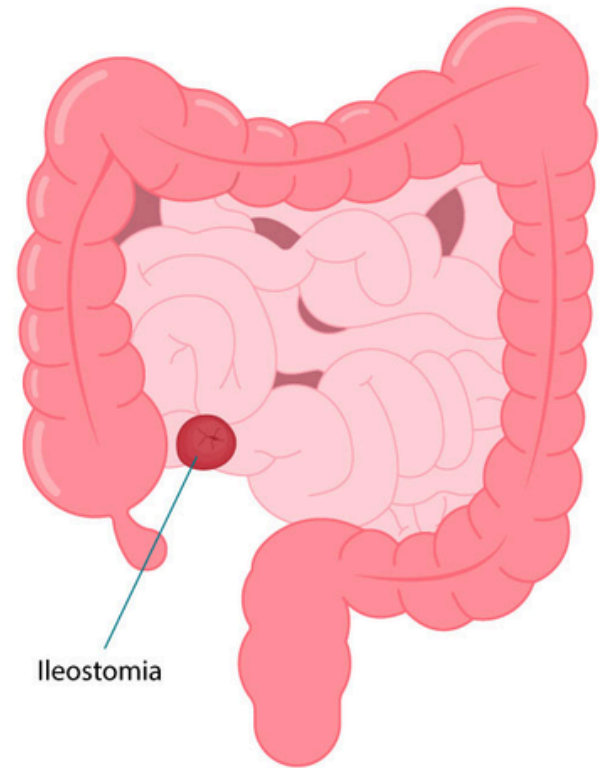
Eliminações através de ostomias (colostomia/ileostomia)



Alterações na Eliminação Intestinal

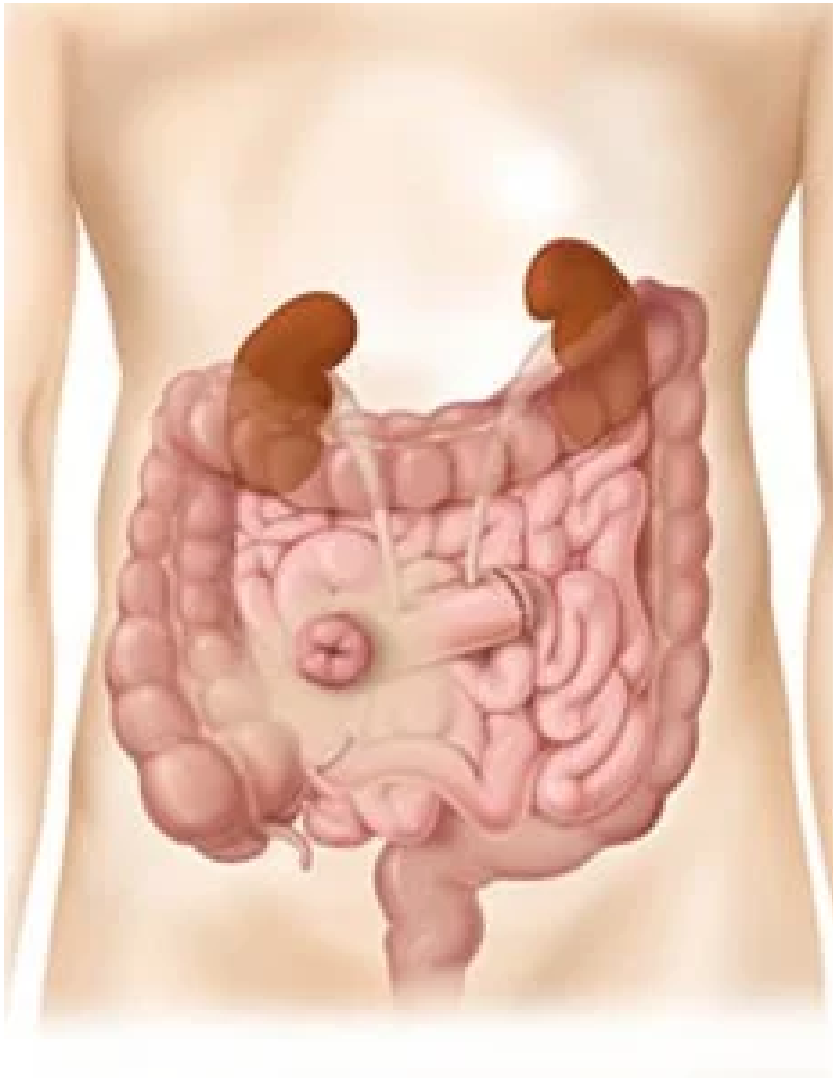


COLOSTOMIA



ILEOSTOMIA

Urostomia



A Urostomia é uma derivação urinária com o objetivo de drenar a urina dos rins para o meio externo.(MACIEL, 2014).

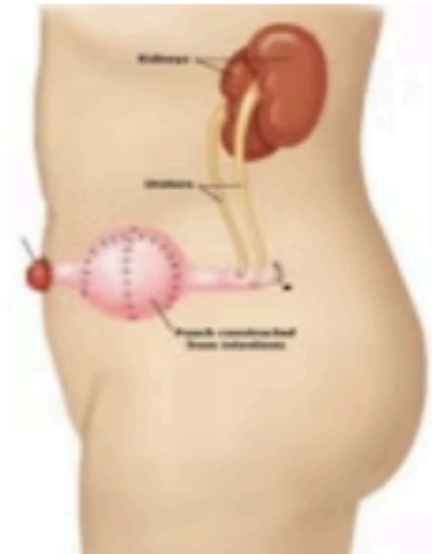
Pode ser de vários tipos:
cistostomia,
ureterosigmoidostomia, entre
outros.

Ureteroileostomia

Na ureteroileostomia ocorre a exteriorização de um segmento do íleo. Esse procedimento também é denominado cirurgia de Bricker. (MACIEL, 2014).



Fonte: Arquivo pessoal do autor (2017).



Fonte: Pereira (2014).

Ureterostomia cutânea bilateral e unilateral

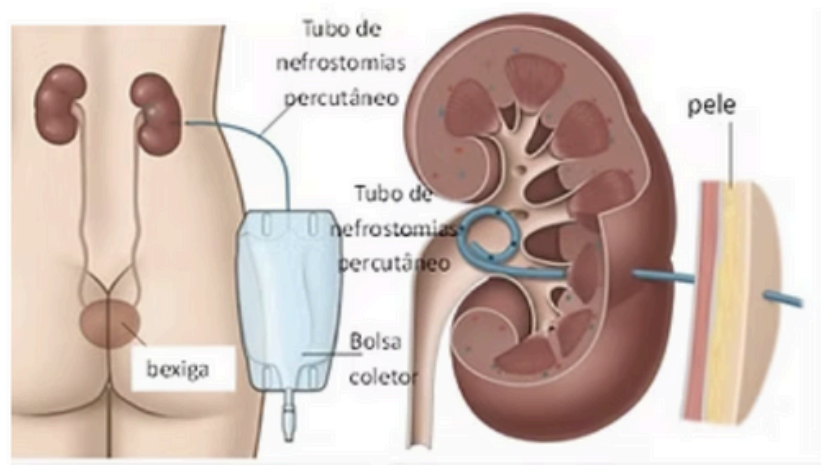
Na ureterostomia cutânea ocorre a exteriorização do ureter na parede abdominal, podendo ser bilateral ou unilateral. (MACIEL, 2014).



Fonte: Assessment Technologies Institute (LLC) (2017)

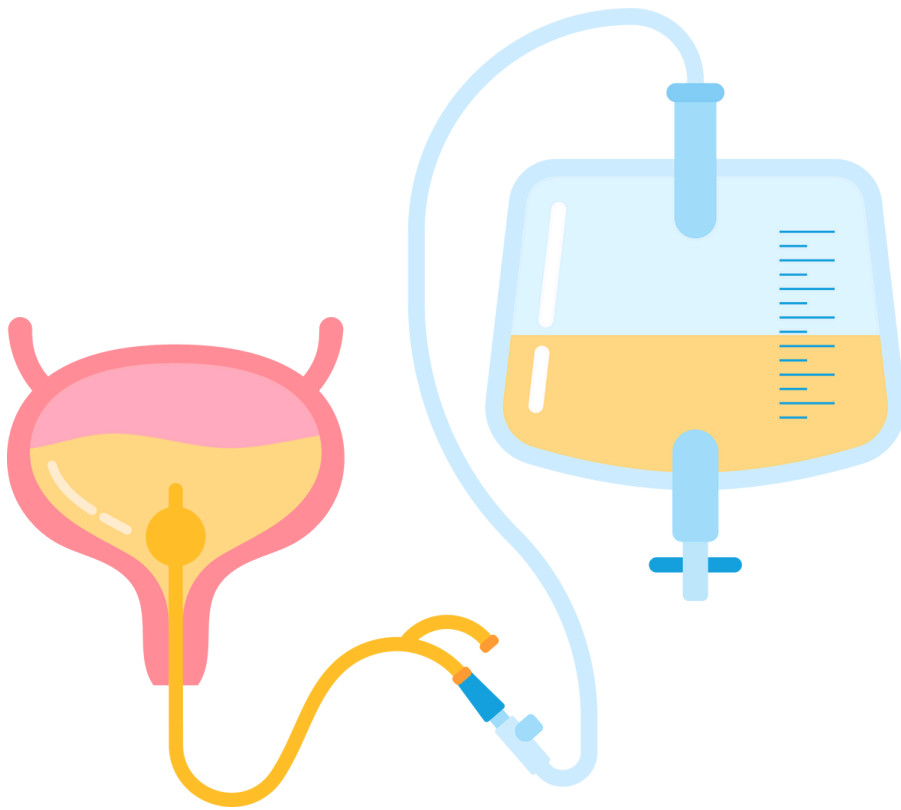
Nefrostomia percutânea

Na nefrostomia, por sua vez, ocorre a drenagem da urina por meio de um cateter uretral inserido na pelve renal, o que é feito por uma incisão no flanco. (LEWIS et al., 2013; MACIEL, 2014).



Fonte: Nefrostomia... (2017).

SVA E SVD





Nutrição Enteral

Fornecimento de nutrientes através de sonda é utilizado por diversos problemas, desde o recém-nascido prematuro incapaz de sugar ou deglutir até o adulto mais idoso com diminuição de nível de consciência.



Nutrição Enteral

- ✓ Consiste na administração de alimentos liquidificados ou de nutrientes de soluções nutritivas com fórmulas quimicamente definidas, por infusão direta no estômago ou intestino delgado, através de sondas.
- ✓ Indicação:
 - ✓ Pacientes com necessidades nutricionais normais ou aumentadas, cuja ingestão por via oral, está impedida ou ineficaz, porém com o restante do TGI anatofuncionalmente aproveitável.

✓ Via Oral:

- ✓ Avaliação prévia;
- ✓ Riscos de bronco aspiração.



Dieta Geral - Permite todos os tipos de alimentos.

Média 6x ao dia.

*Paciente sem restrição



Dieta Branda - Retirada de bebida com cafeína, extrato de carne, frutas cítricas, frituras. (pouco tempero, carne desfiada, sopa, frutas)



*Paciente com dificuldade de mastigar

Dieta Líquida - Clara ou total: fluidos que são líquidos à temperatura do corpo. (Chá, sucos, sopa)



*Paciente pós-cirúrgicos, teste diagnóstico

Dieta Pastosa - Líquida espessa, nenhum pedaço grande de alimento. (Purê de batata, frutas amassadas)

*Pctes incapacitados de mastigar, bebê.



Outras:

- Rica/Pobre em fibras (grãos integrais, legumes, frutas secas, ou sem fibras)
- Restrita em resíduo (fibra sem leite)
- Laxativas

Dieta Caseira

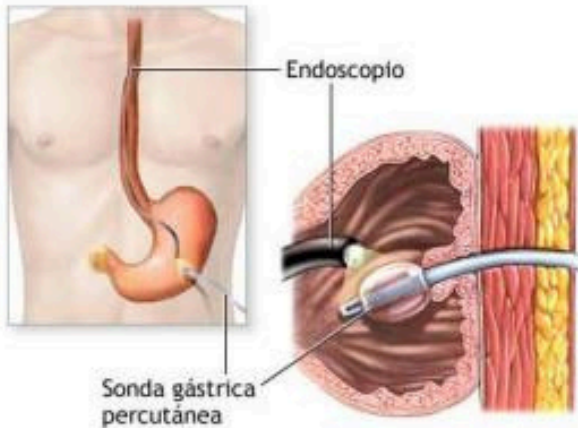
É chamada *in natura e preparada com os alimentos* usuais como legumes, verduras, arroz, carne, frango, leite etc.

Orientada pelo nutricionista, deve ser completa e equilibrada.



✓ Via Enteral;

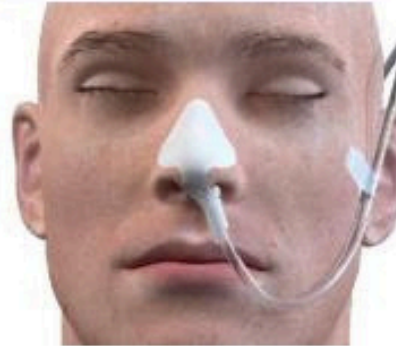
- Sonda Gástrica, mais indicada para drenagem
- Sonda Enteral
- Jejunostomia
- Gastrostomia



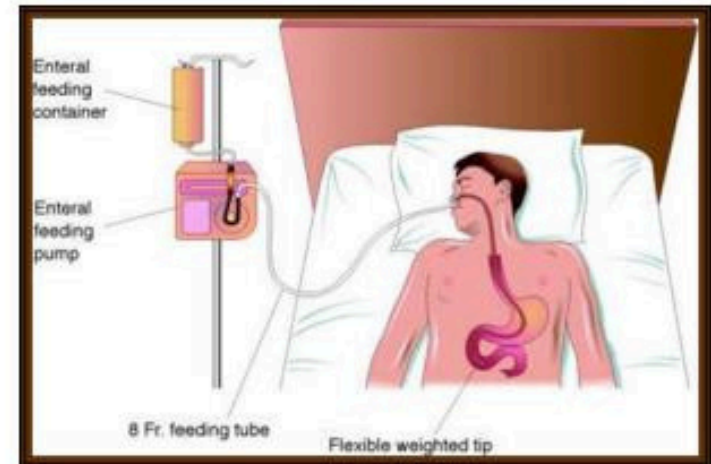
Dieta e Água



SNE ou SNG

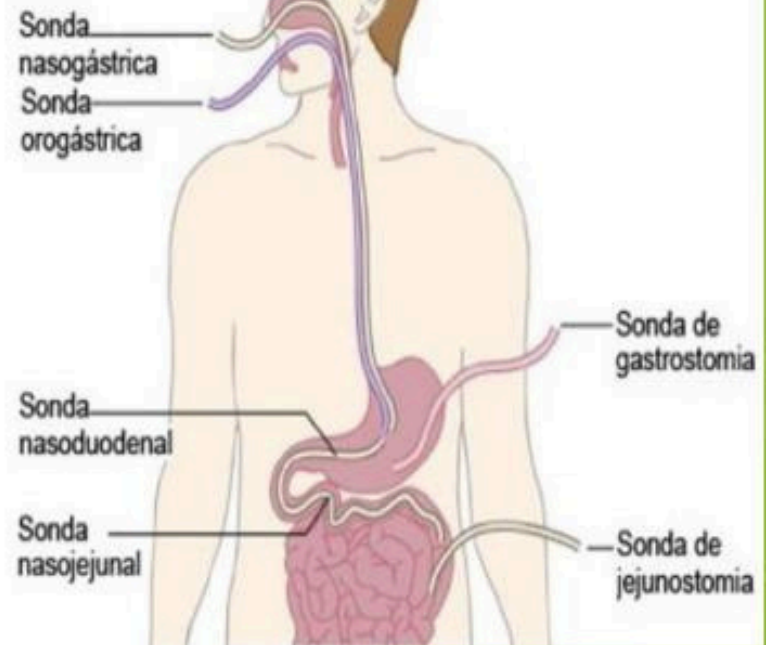


Bombas de Infusão Contínua

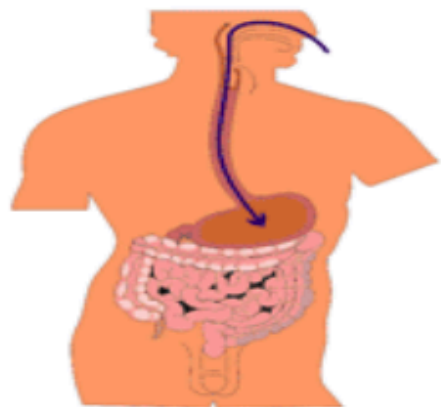


Jejunostomia: sonda é colocada no intestino (jejuno).

Gastrostomia: sonda é colocada diretamente no estômago;

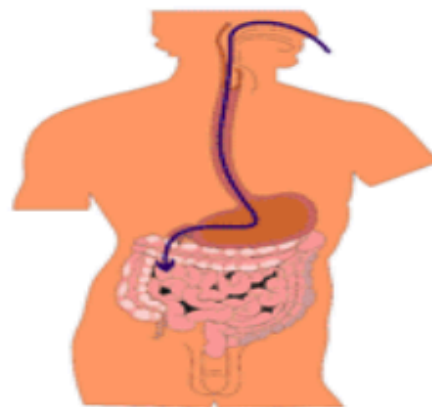


Via Nasogástrica:



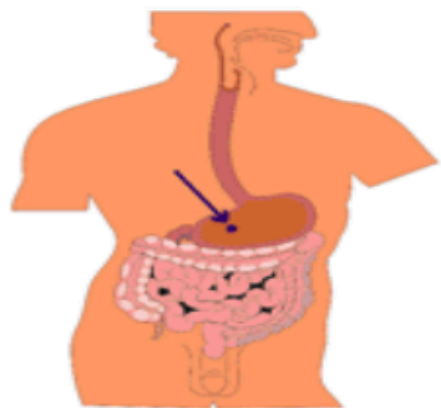
a sonda é passada pelo nariz e se direciona até o estômago.

Via Nasoentérica:



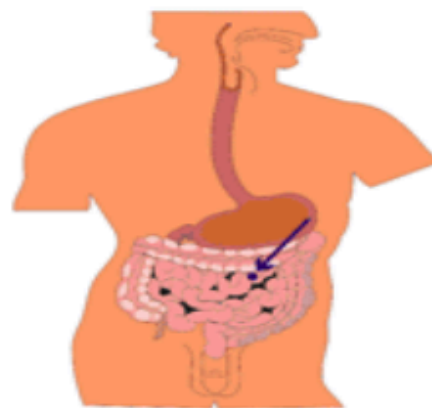
a sonda é passada pelo nariz e se direciona até o intestino delgado.

Gastrostomia:



a sonda é implantada cirurgicamente ou via endoscópica e permanece em um orifício (estoma) diretamente no estômago.

Jenunostomia:



a sonda é implantada cirurgicamente ou via endoscópica e permanece em um orifício (estoma) diretamente no intestino delgado (jejuno).

Nasogástrica

- A sondagem nasogástrica é a passagem de uma sonda através das fossas nasais até o estômago. Além de ser utilizada para a alimentação, pode ser introduzida para remover secreções do estômago, remover doses excessivas de medicamentos ingeridos ou venenos, para esvaziamento gástrico antes de cirurgias e para administração de medicações.

Nasogástrica

- ✓ **Sonda de Levine** - plástico ou borracha, com aberturas localizadas próxima à ponta. Indicadas para uso em um período inferior a 4 semanas.
- ✓ Tamanhos do nº 4 ao 20



Indicação SNG

- ✓ Pacientes incapazes de deglutir;
- ✓ Remover ar e secreções do estômago;
- ✓ Remover doses excessivas de medicamentos ingeridos ou venenos;
- ✓ Esvaziar o estômago antes da cirurgia do TGI.

OBJETIVOS DA SNG



- DRENAR O CONTEÚDO GÁSTRICO
- REALIZAR LAVAGEM GÁSTRICA
- ADMINISTRAR MEDICAMENTOS
- ADMINISTRAR DIETAS

Materiais utilizados

seringa

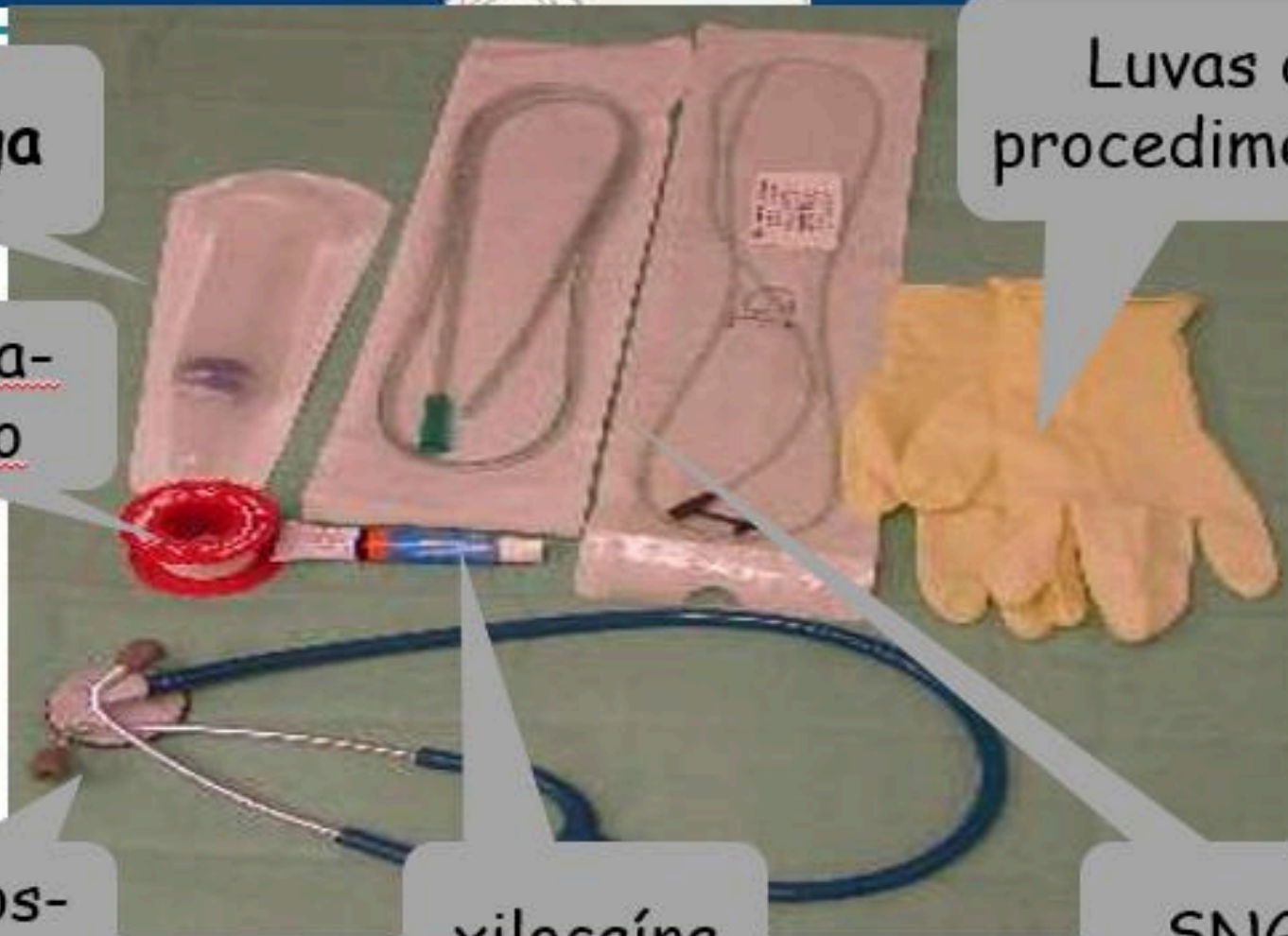
Espara-
drapo

Luvas de
procedimentos

Estetos-
cópio

xilocaína

SNG



Material Necessário

Sonda Nasogástrica



- Sonda nasogástrica (mulher 14 a 16, homem 16 a 18)
- Vaselina ou anestésico gel a 2% (Xilocaína gel)
- Luvas de procedimento
- Esparadrapo ou micropore
- Seringa de 10 ou 20ml
- Estetoscópio
- Gazes
- Cuba rim
- Benzina ou éter
- Água em um copo (se paciente lúcido)
- Tolha/compressa
- Biombo s/n





Intoxicações exógenas

- **Lavagem gástrica**
 - Sonda orogástrica de grosso calibre.
 - Administrar pequenos volumes de SF (100 a 250 ml) e esperar o retorno do líquido.
 - Parar quando o SF voltar limpo.
- Eficácia depende do tempo de ingestão:
 - após 5', recupera-se 90%,
 - após 10', recupera-se 45%,
 - Após 19', recupera-se 30%.
- Após 60' raramente indica-se a lavagem gástrica.

Lavagem Gástrica

Indicações

- ingestão de tóxico potente
- ingestão recente (**até 1-2 horas**), exceto se drogas que retardem o esvaziamento gástrico
- substância não adsorvida pelo carvão ativado (**metais, cáusticos, ácidos inorgânicos, cianeto, álcoois**)

Contra-indicações

- alterações hemorrágicas
- derivados de petróleo
- agentes corrosivos
- cuidado com depressão respiratória, neurológica e/ou agitação

Complicações potenciais

pneumonia aspirativa, perfuração do esôfago/estômago, hipóxia, laringoespasma, arritmia cardíaca, distúrbios hidroeletrólíticos.

Técnica

Crianças: SNG nº 10-14, 10 -15ml/kg ou 100-150 ml/vez, SF morno

Adultos: SNG nº 16-18, utilizar 200-300 ml/vez, SF

Nasoentérica

A sondagem nasoentérica é a passagem de uma sonda através das fossas nasais, geralmente até o jejuno com a finalidade de alimentar e hidratar. Esta sonda causa menos traumas que a sonda nasogástrica, podendo permanecer por mais tempo, e reduz o risco de regurgitação e aspiração traqueal.

A sondagem nasoentérica permite a administração de nutrientes pela via digestiva normal. Ela pode ser utilizada em qualquer faixa etária para a solução de diferentes problemas.

Sua finalidade é a manutenção ou correção do estado nutricional. De maneira geral, os indivíduos que conservam o aparelho digestivo em funcionamento, porém não são capazes de ingerir os nutrientes adequados pela boca, podem se beneficiar da nutrição via sonda nasoenteral.

A sondagem nasoenteral é indicada em casos de pré e pós operatório de diversas cirurgias, estado comatoso, anorexia, dentre outros.

Sonda de Dobbhoff - poliuretano e silicone, possui ponta pesada e flexível, fio guia em aço inox, suporta longos períodos em contato com o suco gástrico, pode ser usada por até 4 meses (enquanto estiver íntegra, limpa e translúcida).



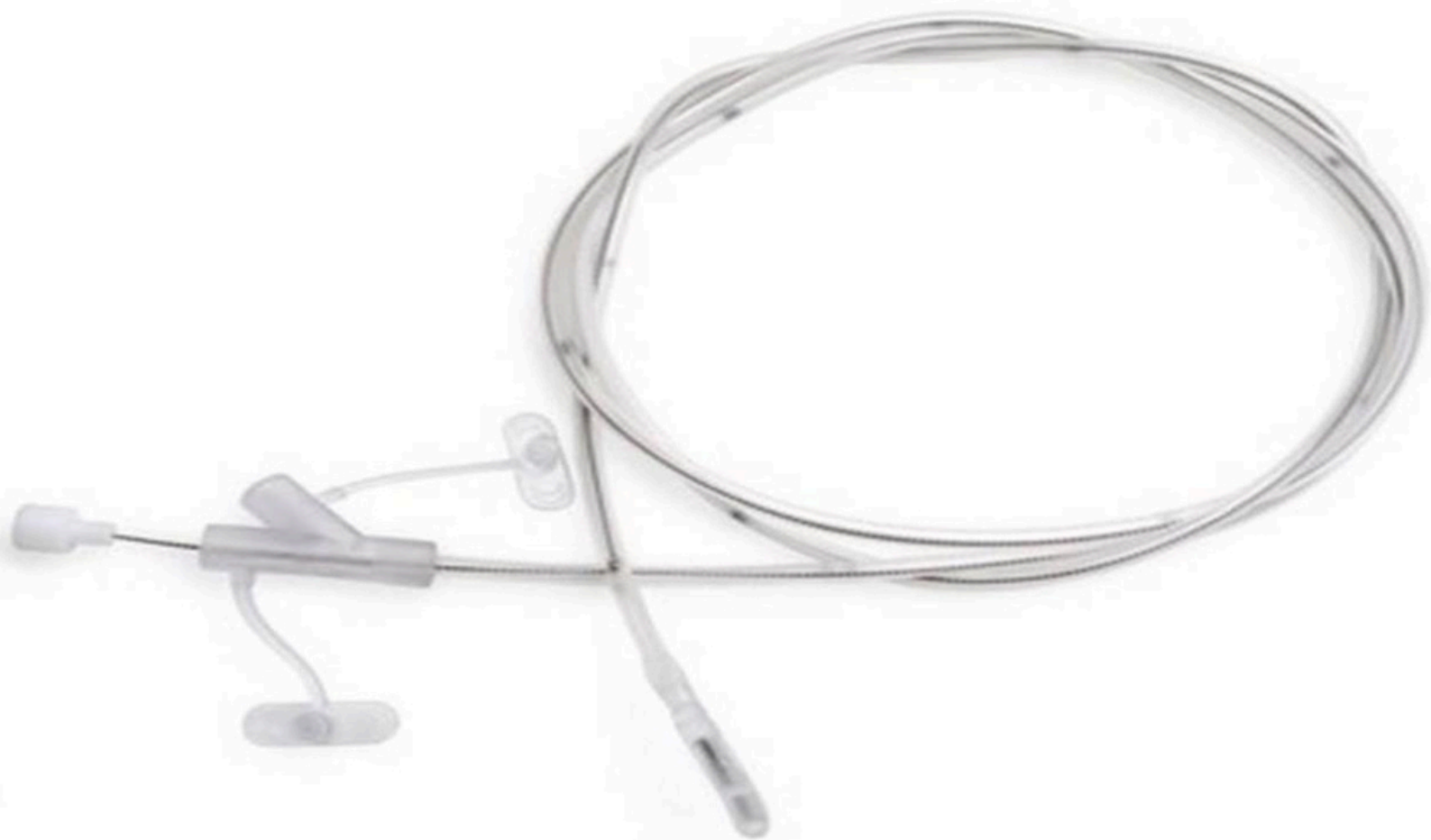
Materiais

- Bandeja contendo sonda nasoenteral em calibre adequado
- Seringa de 20 ml
- Pacote de gaze
- Lubrificante
- Micropore para fixação
- Estetoscópio
- Tesoura

Observações

- Riscos:
 - ▶ Obstrução da sonda
 - ▶ Remoção acidental da sonda
 - ▶ Úlceração nasal

- Prevenção de agravo:
 - ▶ Seguir procedimento técnico
 - ▶ Fixar a sonda adequadamente
 - ▶ Inspeccionar narinas para avaliar a necessidade de aliviar pressões da sonda
 - ▶ Tratar agitação psicomotora







- 
- Tratamento da não conformidade:
 - ► Comunicar as intercorrências e realizar os registros necessários
 - ► Em caso de remoção acidental repassar a sonda caso necessário
 - ► Lavar a sonda com 20 mL de água filtrada em caso de obstrução
 - ► Assegurar tratamento dos agravos e atenção à família

- Sempre usar EPI;
- Realizar os registros necessários após os procedimentos;
- Manter o local em ordem;

- ► Sinais de mau posicionamento da sonda:
 - • Cianose facial e de extremidades;
 - • Tosse e dificuldade respiratória;
 - • Dificuldade de injetar ar para teste de ruído no fundo gástrico;
 - • Na presença destes sinais retirar a sonda e tentar introdução novamente;

- Riscos:

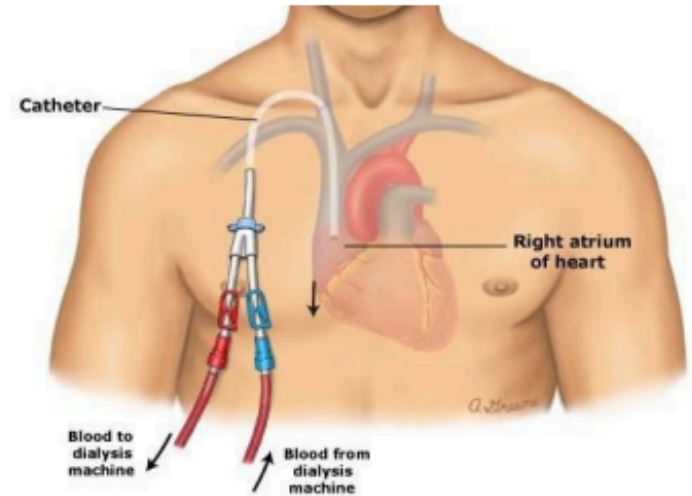
- ► Obstrução da sonda
- ► Remoção acidental da sonda
- ► Úlceras nasais

- Prevenção de agravos:

- ► Seguir procedimento técnico
- ► Fixar a sonda adequadamente
- ► Inspeccionar narinas para avaliar a necessidade de aliviar pressões da sonda
- ► Tratar agitação psicomotora

✓ Via Parenteral;

- Acesso Venoso Central ou periférico
 - Indicações
 - Administração
 - Intercorrências do acesso



Tipos de dieta

Dieta Industrializada Sistema Aberto



Dieta Industrializada Sistema Fechado



ABERTO

- ▶ Exige manipulação prévia à administração de uso imediato ou segundo recomendações do fabricante (RDC nº63, 2000).

FECHADO

- ▶ Trata-se de NE industrializada, estéril em recipiente hermeticamente fechado com um conector para o equipo de infusão.

EasyBag



Vias



Pinça Rolete



Clamp

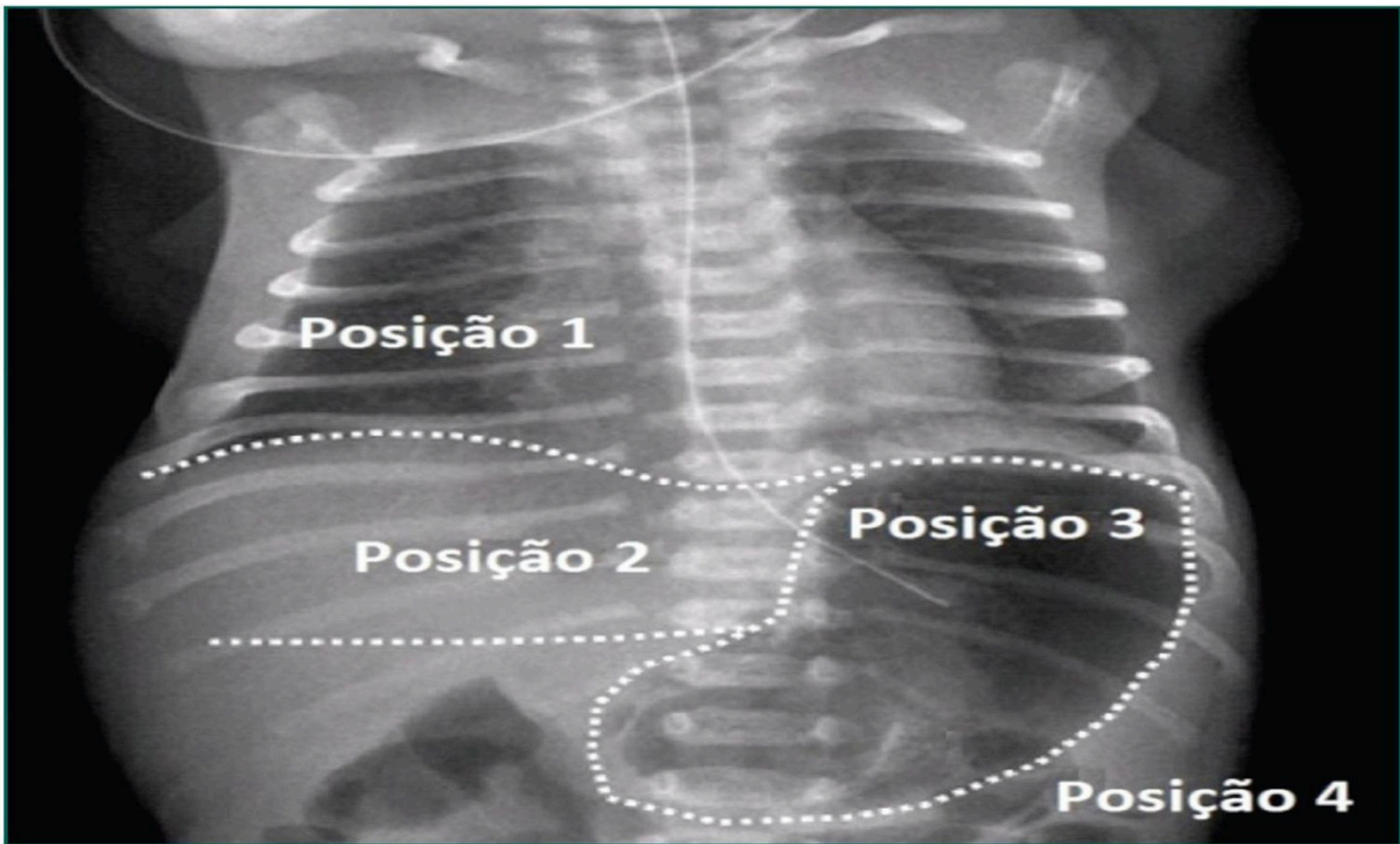


Gravitacional



Bolus



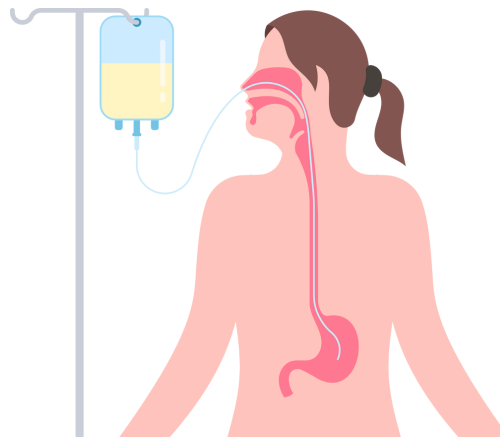


- Posição 1 - Sonda locada acima do diafragma e junção gastresofágica;
Posição 2 - Sonda locada sob a junção gastroesofágica e antes corpo do estômago;
Posição 3 - Sonda locada no corpo do estômago (posição correta);
Posição 4 - A sonda toca a grande curvatura do estômago, ou a ponta encontra-se na região do esfíncter pilórico;
Posição 5 - Impossibilidade de avaliação do posicionamento através da radiografia.



Cuidados para fixação da sonda na narina:

- Integridade da pele;
- Prevenção de lesão de aba de nariz;
- Podem haver acidentes, quanto ao tracionamento da sonda.





✓ Via Parenteral;

- Sinais flogísticos no sítio de inserção do cateter.

- Dor local,

- Rubor;

- Calor;

- Edema;

- Vermelhidão;

- Presença de Exsudato.

- Nestes casos é necessário avaliar e ponderar a possibilidade de trocar cateter de local, conforme procedimento médico.



✓ **Via Parenteral - Indicação:** para pacientes que conservam o aparelho digestivo em funcionamento e não é capaz de ingerir pela boca os nutrientes necessários.

- ✓ Clínicas e Cirúrgicas
- ✓ Jejum prolongado;
- ✓ Pós - operatório de cirurgias de médio e grande porte;
- ✓ Politraumatismos;
- ✓ Concomitante ao manejo clínico de disfunções graves;
- ✓ Pacientes em cuidados críticos;
- ✓ Pacientes grandes queimados;
- ✓ Suporte nutricional na oncologia.

Dieta Industrializada

Sistema Fechado - Parenteral



Observar na embalagem da dieta:

https://www.youtube.com/watch?v=zLKGsb0r_j4

- Validade e integridade;
- Aspecto do líquido;
- Violação;
- Nome do paciente;
- Data;
- Confirmar via de administração.

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR Sonda

- ✓ Medicamentos líquidos: aspirar o volume prescrito com a seringa e injetar pela sonda;
- ✓ Comprimidos e drágeas: amassar e dissolver em água, misturando bem; aspirar com a seringa e injetar pela sonda;
- ✓ Administrar os medicamentos um a um;
- ✓ Injetar água após cada medicação, para evitar que se misturem na sonda, podendo obstruir a mesma;
- ✓ Existem medicamentos que não devem ser administrados pela sonda devido a problemas na absorção.

Orientações e Cuidados de Enfermagem

- ✓ Em pacientes com suspeita de TCE, (fratura de base de crânio) é recomendado a sondagem oral gástrica;
- ✓ Em pacientes com suspeita de Trauma raquimedular, não elevar o decúbito;
- ✓ Durante a passagem da sonda, o paciente pode sentir náuseas por estimulação do nervo vago.
- ✓ Caso isso ocorra, interromper o procedimento temporariamente. Ocorrendo vômito, retirar a sonda e atender o paciente, retomando o procedimento mediante avaliação.

- Posicionar o paciente confortavelmente no leito com a cabeceira elevada 30° (afim de evitar regurgitação) e proteger o tórax com a toalha;
- Posicionar o frasco de dieta a 45cm da cama do paciente;
- No término da infusão da dieta ou após administração de medicamentos, lavar a sonda com 30 a 50 ml de água filtrada;
- Clampar a sonda imediatamente sempre que for desconectar a seringa, para evitar a entrada de ar e/ou refluxo;
- Observar intercorrências durante a infusão da dieta;
- Estimular ou realizar a higiene oral do paciente;
- Checar na prescrição a instalação da dieta e anotar no prontuário os cuidados de enfermagem

Compete ao Enfermeiro:

- a) Participar da escolha da via de administração da NE em consonância com o médico responsável pelo atendimento ao paciente e a EMTN;
- b) Estabelecer o acesso enteral por via oro/gástrica para a administração da NE, conforme procedimentos préestabelecido;
- c) Solicitar e encaminhar o paciente para exame radiológico visando a confirmação da localização da sonda;
- d) Participar da instalação do acesso por estomia, realizada pelo médico, utilizando-se de técnica asséptica, de preferência no Centro Cirúrgico, obedecendo-se a procedimento escrito estabelecido em consonância com a CCIH;
- e) Garantir que a via de acesso da NE seja mantida;
- f) Garantir que a administração da NE seja realizada no prazo estabelecido, recomendando-se a utilização Bomba de infusão;
- g) Garantir que a troca da NE, sondas e equipo seja realizada em consonância com o pré-estabelecido pela EMTN, em conjunto com a CCIH;
- h) Prescrever os cuidados de enfermagem.
- i) Registrar em prontuário todas as ocorrências e dados referentes ao paciente e à TNE.

- 
- https://www.youtube.com/watch?v=zLKGsb0r_j4
 - <https://www.youtube.com/watch?v=IpYX28U-lWc>
 - <https://www.youtube.com/watch?v=DYbVe-MNcuA>

Risco para Aspiração relacionado depressão dos reflexos da laringe e da glote, secundária a sondas de alimentação.

Meta: O indivíduo não deverá apresentar aspiração.

Intervenções Enfermagem:

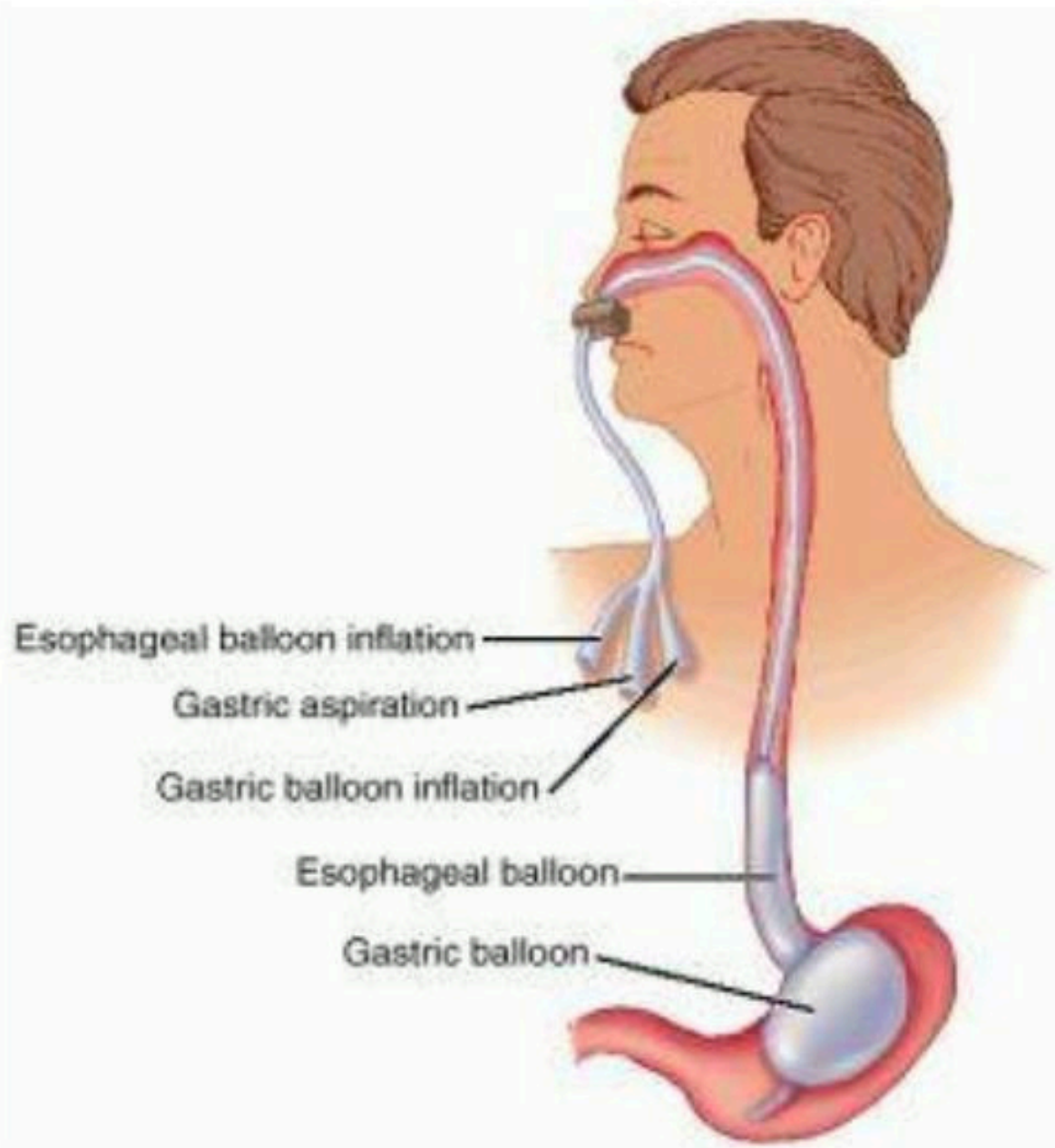
1. Verificar a posição adequada do pacientes antes do início da alimentação.
2. Manter o paciente em posição 45° sempre que a infusão for contínua e por trinta minutos após a refeição intermitente.
3. Desligar a dieta entre 30 minutos e 1 hora antes do banho no leito e realização de exames.
4. Desligar a dieta e abrir a sonda em sifonagem em caso de êmese.
5. Monitorar a função gastrointestinal: ausculta, palpação, percussão e eliminação.
6. Explorar as características e frequência das evacuações.
7. Avaliar da posição a sonda e posição do paciente, verificar velocidade do fluxo.
8. Determinar a capacidade do paciente para tolerar a fórmula avaliando distensão e perímetro abdominal, náuseas e vômitos, diarreia e constipação, auscultar abdome evidenciando presença ou não de movimentos peristálticos, observar sinais de desidratação como mucosas secas e eliminação vesical diminuída.

Sonda de Sengstaken-Blakemore



- - é uma sonda utilizada especificamente para o tratamento de sangramentos de varizes esofagianas, possuindo três luzes com dois balões, sendo uma luz para insuflar o balão gástrico e outra para o balão esofageano. A terceira luz – lavagem gástrica







obrigada !!

